

Framework profissional para elaboração de guidelines clínicos

Modelo integrado de escopo, evidência, terapêutica, complicações e implementação

Projeto-base para diretrizes clínicas completas
Com regra explícita de aplicabilidade por diagnóstico

Manus AI
18 de setembro de 2026

Sumário

1	Resumo executivo	1
2	Como usar este framework	1
2.1	Estados de aplicabilidade	1
2.2	Produtos recomendados	2
3	Parte I — Governança, identidade e escopo	2
3.1	Identificação da guideline	2
3.2	Escopo e perguntas clínicas	2
3.3	Painel multiprofissional e partes interessadas	2
3.4	Conflitos de interesse e independência	2
3.5	Ética, equidade e direitos	3
4	Parte II — Base científica e processo	3
4.1	Busca e seleção da evidência	3
4.2	Avaliação da evidência	3
4.3	Formulação das recomendações	3
4.4	Revisão externa e controle de qualidade	3
4.5	Atualização viva	3
5	Parte III — Conteúdo clínico específico do diagnóstico	3
5.1	Definições, classificação e codificação	3
5.2	Epidemiologia, etiologia e fisiopatologia	4
5.3	Fatores de risco, proteção e prevenção	4
5.4	Apresentação clínica	4
5.5	Triagem e sinais de alarme	4
5.6	Diagnóstico diferencial	4
5.7	Probabilidade pré-teste e critérios diagnósticos	4
5.8	Exames complementares	4
5.9	Imagem, procedimentos diagnósticos e sedação	4
5.10	Gravidade, escores e prognóstico	4
6	Parte IV — Módulo terapêutico completo	5
6.1	Regra de inclusão terapêutica	5
6.2	Ficha terapêutica obrigatória	5
6.3	Status regulatório e uso off-label	5
6.4	Tratamento inicial e definitivo	5
6.5	Falha terapêutica e resgate	6
6.6	Procedimentos, cirurgia e reabilitação	6
6.7	Terapias não farmacológicas	6
6.8	Antimicrobial stewardship	6
7	Parte V — Complicações e desfechos adversos	6
7.1	Mapa de complicações	6
7.2	Ficha de manejo de cada complicação	6
7.3	Escalonamento	6
7.4	Prevenção de complicações e eventos adversos	6
8	Parte VI — Populações e cenários especiais	7

9	Parte VII — Seguimento, alta e continuidade	7
9.1	Reavaliação	7
9.2	CrITÉrios de alta	7
9.3	Educação e decisão compartilhada	7
10	Parte VIII — Segurança, tecnologia e implementação	7
10.1	Segurança do paciente	7
10.2	Farmacovigilância	7
10.3	Telemedicina, imagens e inteligência artificial	7
10.4	Indicadores de qualidade	8
10.5	Implementação e auditoria	8
10.6	Avaliação econômica	8
11	Parte IX — Pacote editorial e anexos	8
11.1	Formulário de recomendação	8
11.2	Formulário de intervenção terapêutica	8
11.3	Formulário de complicação	9
12	Auditoria de completude antes da publicação	9
13	Referências de elaboração	10
14	Nota final de uso	11

1 Resumo executivo

Este documento consolida e amplia os tópicos necessários para planejar, desenvolver, redigir, revisar, publicar, implementar e atualizar uma guideline clínica profissional. Ele não é uma diretriz para uma doença específica. É um **framework reutilizável** para construir diretrizes diagnósticas e terapêuticas sem omissões relevantes e sem inserir conteúdo incompatível com a condição estudada.

O framework adota uma regra central: **o conjunto final deve ser específico para o diagnóstico**. Um item só deve aparecer quando tiver pertinência clínica, evidência ou justificativa de elaboração para aquela condição. Se um tópico não existir, não for condizente, não alterar a decisão clínica ou não puder ser sustentado por fonte confiável, ele deve ser omitido da guideline final. Não se deve preencher lacunas com texto genérico, inferência ou uma recomendação de outra doença.

A estrutura segue boas práticas internacionais de desenvolvimento, relato e avaliação de guidelines. O handbook da Organização Mundial da Saúde descreve um processo passo a passo para planejar, desenvolver e publicar recomendações. [1] O RIGHT organiza requisitos de relato em informação básica, contexto, evidência, recomendações, revisão, qualidade, financiamento e conflitos de interesse. [2] O AGREE II avalia escopo, participação, rigor de elaboração, clareza, aplicabilidade e independência editorial. [3] No Brasil, a CONITEC mantém materiais oficiais para elaboração, adaptação, avaliação e graduação de recomendações em diretrizes clínicas. [4] [5]

Regra de ouro — aplicabilidade diagnóstica

A guideline não deve ser uma lista fixa aplicada a qualquer doença. Para cada tópico, registrar internamente se ele é [aplicável], [condicional], [não aplicável] ou [não sustentado]. Na versão publicada, incluir apenas os itens aplicáveis e os condicionais que tenham critérios claros. O status [não aplicável] não precisa ser impresso no corpo clínico; ele serve para a auditoria de completude.

2 Como usar este framework

O documento deve ser usado em cinco passagens. Primeiro, definir o diagnóstico, a população e as decisões clínicas que a guideline precisa apoiar. Segundo, preencher o mapa de aplicabilidade e excluir itens incompatíveis. Terceiro, pesquisar e graduar a evidência. Quarto, escrever recomendações operacionais, incluindo tratamento, terapêutica **off-label** e complicações quando pertinentes. Quinto, revisar a diretriz com especialistas, usuários finais e controle de elaboração antes da publicação.

A guideline final deve conter recomendações acionáveis. Cada recomendação precisa declarar a população, a situação clínica, a intervenção, a alternativa ou comparador, o desfecho esperado, a força da recomendação, a certeza da evidência, as exceções, os riscos, os recursos necessários e a fonte.

2.1 Estados de aplicabilidade

Estado	Uso	Regra editorial
Aplicável	O diagnóstico apresenta o item e ele modifica a conduta.	Incluir no corpo da guideline.
Condicional	O item ocorre apenas em subgrupo,	Incluir somente com critérios de acionamento.

Estado	Uso	Regra editorial
	estágio ou contexto definido.	
Não aplicável	O item não existe ou não é coerente com a doença.	Omitir da versão final; não criar uma seção vazia.
Não sustentado	Há hipótese, prática local ou evidência insuficiente.	Não transformar em recomendação; registrar como lacuna ou pesquisa.

2.2 Produtos recomendados

O projeto profissional deve produzir, conforme a necessidade, uma versão integral, um resumo executivo, um fluxograma de decisão, checklists assistenciais, tabelas terapêuticas, material para pacientes, instrumentos de auditoria e um registro de alterações. Esses produtos devem derivar da mesma fonte editorial para evitar divergências.

3 Parte I — Governança, identidade e escopo

3.1 Identificação da guideline

Registrar título, diagnóstico, população, cenário, instituição responsável, versão, data de entrada em vigor, data de revisão prevista, autores, revisores, financiadores, contatos e controle de alterações. O título deve deixar claro se o documento é uma guideline, um protocolo institucional, uma via clínica, uma declaração de consenso ou um instrumento de triagem.

3.2 Escopo e perguntas clínicas

Definir o que está dentro e fora do documento. Formular as perguntas clínicas de forma estruturada, especificando população, intervenção, comparador, desfecho e contexto. Separar perguntas de rastreamento, diagnóstico, classificação de risco, prognóstico, tratamento, prevenção, seguimento e organização do cuidado. O escopo deve declarar idade, sexo quando relevante, gestação, imunidade, comorbidades, cenário assistencial, nível de complexidade e recursos disponíveis. Se uma população não foi estudada, não extrapolar silenciosamente; informar a limitação e criar uma seção específica apenas se houver base suficiente.

3.3 Painel multiprofissional e partes interessadas

Definir participação de especialistas clínicos, enfermagem, farmácia, diagnóstico, cirurgia, reabilitação, atenção primária, gestão, desenvolvimento de guidelines, economia da saúde, pacientes e cuidadores, conforme a doença. Registrar como as contribuições foram coletadas e como divergências foram resolvidas.

3.4 Conflitos de interesse e independência

Coletar, declarar e gerenciar conflitos financeiros, profissionais, acadêmicos e institucionais. Explicar quem financiou o trabalho, se o financiador teve influência sobre recomendações e quais medidas preservaram a independência editorial.

3.5 Ética, equidade e direitos

Avaliar consentimento, assentimento, privacidade, proteção de dados, populações vulneráveis, barreiras de acesso, justiça distributiva, acessibilidade e possíveis efeitos desiguais entre grupos. Incluir equidade somente quando houver implicação para o diagnóstico, tratamento ou implementação; não adicionar uma seção abstrata sem consequência prática.

4 Parte II — Base científica e processo

4.1 Busca e seleção da evidência

Registrar bases consultadas, data da busca, estratégias, descritores, critérios de inclusão e exclusão, idiomas, população, desenho dos estudos e processo de seleção. Priorizar diretrizes atuais, revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos diagnósticos, coortes, registros e fontes regulatórias, conforme a pergunta.

4.2 Avaliação da evidência

Para cada recomendação, registrar desfechos críticos, benefícios, danos, precisão diagnóstica, consistência, aplicabilidade, risco de viés, imprecisão, indireção e viés de publicação. Diferenciar evidência direta da extrapolada e consenso de especialistas da evidência empírica.

4.3 Formulação das recomendações

Escrever recomendações com verbo operacional, população definida, condição de acionamento, ação, alternativa, tempo, intensidade, duração e exceção. Informar força da recomendação e certeza da evidência. Quando houver escolhas equivalentes, explicitar os critérios de seleção.

4.4 Revisão externa e controle de qualidade

Submeter o rascunho a revisão clínica, de elaboração, farmacêutica, de implementação e, quando pertinente, de pacientes. Registrar comentários, resposta dos autores, alterações realizadas e itens não incorporados com justificativa.

4.5 Atualização viva

Definir a validade temporal, responsável pela vigilância, gatilhos de revisão e periodicidade. Atualizar antecipadamente após alerta de segurança, mudança regulatória, novo tratamento, mudança de resistência, evidência de alto impacto ou alteração importante de disponibilidade.

5 Parte III — Conteúdo clínico específico do diagnóstico

5.1 Definições, classificação e codificação

Incluir definição clínica, operacional e etiológica; sinônimos; casos suspeitos, prováveis, confirmados e descartados; doença aguda, subaguda, crônica e recorrente; critérios de remissão, controle, cura e falha; classificações anatômicas, funcionais ou de gravidade; e códigos diagnósticos quando forem úteis para documentação, notificação ou auditoria.

Omitir classificações que não alterem prognóstico, tratamento ou comunicação clínica. Não criar estágios numéricos apenas para dar aparência de completude.

5.2 Epidemiologia, etiologia e fisiopatologia

Abordar incidência, prevalência, distribuição por idade e região, mortalidade, morbidade, impacto funcional, agentes causais, mecanismos, vias de transmissão, anatomia relevante e mudanças conforme vacinação, comorbidades ou exposição. Diferenciar fatores de risco de causas comprovadas.

5.3 Fatores de risco, proteção e prevenção

Incluir fatores modificáveis e não modificáveis, histórico familiar, exposições, procedimentos prévios, medicamentos, vacinação, prevenção primária, prevenção de recorrência, profilaxia, educação e estratégias de redução de transmissão quando forem pertinentes ao diagnóstico.

5.4 Apresentação clínica

Descrever sintomas iniciais, sinais típicos e atípicos, cronologia, exame físico dirigido, apresentações por faixa etária, imunossupressão, gestação, comorbidades, doença recorrente, doença silenciosa e situações em que o exame pode ser limitado. Destacar achados que mudam a urgência ou a conduta.

5.5 Triage e sinais de alarme

Definir critérios de atendimento imediato, instabilidade, sepsis, perda funcional, dor desproporcional, progressão rápida, incapacidade de hidratação, exame não confiável, falha terapêutica, necessidade de terapia intensiva e transferência. O diagnóstico deve ser organizado por prioridade clínica, não apenas por sequência de exames.

5.6 Diagnóstico diferencial

Listar condições infecciosas, inflamatórias, autoimunes, neoplásicas, traumáticas, alérgicas, tóxicas, metabólicas, congênitas e relacionadas a medicamentos somente quando forem plausíveis para aquele diagnóstico. Identificar diagnósticos que não podem ser perdidos e o achado que os diferencia.

5.7 Probabilidade pré-teste e critérios diagnósticos

Explicar como a história e o exame mudam a probabilidade. Definir critérios clínicos, laboratoriais, radiológicos, microbiológicos, anatomopatológicos, genéticos ou moleculares, conforme aplicável. Declarar sensibilidade, especificidade, limitações e quando um resultado negativo não exclui a condição.

5.8 Exames complementares

Para cada exame, especificar indicação, momento, preparo, amostra, técnica, referência, interpretação, falso positivo, falso negativo, repetição, risco, contraindicação, disponibilidade, tempo para resultado e impacto na decisão. Não incluir exames que não alterem diagnóstico, prognóstico ou tratamento.

5.9 Imagem, procedimentos diagnósticos e sedação

Quando houver imagem, definir técnica, contraste, radiação, proteção, função renal, alergia, sedação, achados críticos, prazo de laudo e alternativa quando o recurso não estiver disponível. Para procedimentos, informar indicação, equipe, preparo, consentimento, coleta de material, complicações e recuperação.

5.10 Gravidade, escores e prognóstico

Definir categorias de gravidade e fatores de progressão, falha, internação, cirurgia, perda funcional, recorrência, reinternação e sequela. Para cada escore, registrar população de desenvolvimento, validação, desfecho, variáveis, pontuação, corte, discriminação, calibração, limitações e necessidade de validação local.

Um escore nunca deve substituir um sinal crítico de emergência, instabilidade ou perda de função. Se não houver escore validado para o diagnóstico, declarar isso e usar critérios clínicos transparentes.

6 Parte IV — Módulo terapêutico completo

6.1 Regra de inclusão terapêutica

Toda terapêutica pertinente deve ser considerada, mas somente entra na versão final quando estiver ligada ao diagnóstico e à decisão clínica. O módulo pode conter tratamento etiológico, antimicrobiano, antiviral, antiparasitário, antifúngico, imunomodulador, anti-inflamatório, antineoplásico, hormonal, antitrombótico, analgésico, suporte fisiológico, nutrição, reabilitação, terapia psicológica, medidas ambientais, prevenção, procedimento, cirurgia, radioterapia ou cuidados paliativos — **apenas quando aplicáveis**.

Se uma modalidade não existir para a doença, ela deve ser omitida. Se existir apenas em subgrupo, deve aparecer com critérios. Se não houver evidência suficiente, deve ser apresentada como incerteza, opção de pesquisa ou prática especializada, nunca como tratamento padrão.

6.2 Ficha terapêutica obrigatória

Para cada intervenção incluída, registrar:

- objetivo clínico e desfecho esperado;
- indicação precisa e população elegível;
- momento de início e prioridade;
- dose, faixa, unidade, via, intervalo e duração, quando aplicável;
- limite máximo, ajuste por peso, idade, função renal ou hepática;
- preparo, diluição, administração e compatibilidades;
- contraindicações, precauções e interações;
- monitorização de eficácia e toxicidade;
- critérios para manter, trocar, descalonar, suspender ou reiniciar;
- alternativa em alergia, falha, contraindicação ou indisponibilidade;
- necessidade de especialista, procedimento ou internação;
- acesso, custo, disponibilidade e nível de atenção;
- força da recomendação e certeza da evidência;
- status regulatório e fonte específica.

6.3 Status regulatório e uso off-label

Identificar explicitamente cada intervenção como: aprovada para a indicação e faixa etária; aprovada para outra indicação ou faixa etária e usada **off-label**; recomendada por guideline ou protocolo institucional; uso excepcional ou compassivo; investigação clínica; ou não recomendada.

Uma recomendação **off-label** deve declarar o motivo clínico, a evidência que sustenta o uso, a população estudada, a diferença em relação à bula, a dose e o regime descritos na fonte, os riscos conhecidos, as alternativas aprovadas, o consentimento ou registro exigido localmente e a necessidade de revisão por especialista. Nunca apresentar **off-label** como se fosse aprovação regulatória, nem ocultar que a evidência é indireta.

6.4 Tratamento inicial e definitivo

Descrever medidas de suporte, estabilização, analgesia, febre, hidratação, nutrição, oxigênio, isolamento, tratamento etiológico, tratamento definitivo, terapia adjuvante, descalonamento, transição de via, duração, critérios de interrupção e plano após a alta. Separar alternativas em vez de somar esquemas.

6.5 Falha terapêutica e resgate

Definir tempo de resposta esperado, progressão, ausência de resposta, intolerância, toxicidade, resistência, erro diagnóstico e necessidade de novo exame. Especificar quando repetir culturas, ampliar cobertura, mudar classe, realizar procedimento, consultar especialista, internar ou transferir.

6.6 Procedimentos, cirurgia e reabilitação

Quando aplicáveis, registrar indicação, urgência, contraindicações, preparação, consentimento, anestesia, técnica em nível apropriado, coleta de material, riscos, cuidados pós-procedimento, critérios de reintervenção, reabilitação e seguimento funcional. Omitir cirurgia ou reabilitação se não fizerem parte da doença, mas não omitir complicações do tratamento que possam exigir esses recursos.

6.7 Terapias não farmacológicas

Incluir medidas comportamentais, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, suporte nutricional, cuidado de feridas, educação, ergonomia, psicoterapia, cessação de exposição e medidas ambientais somente quando houver benefício ou recomendação para o diagnóstico.

6.8 Antimicrobial stewardship

Quando houver infecção, definir agente provável, coleta de cultura, antibiograma local, cobertura necessária, risco de resistência, dose, ajuste, monitorização, descalonamento, troca para via oral, duração mínima e máxima e critérios de suspensão. Não prescrever antimicrobiano sem indicação ou prolongar tratamento por inércia.

7 Parte V — Complicações e desfechos adversos

7.1 Mapa de complicações

Listar complicações locais, sistêmicas, neurológicas, funcionais, infecciosas, trombóticas, hemorrágicas, metabólicas, cirúrgicas, medicamentosas e de longo prazo apenas quando forem plausíveis para o diagnóstico. Para cada uma, informar frequência ou relevância, fatores de risco, prevenção, sinais de reconhecimento, exame confirmatório, tratamento inicial, tratamento definitivo e seguimento.

7.2 Ficha de manejo de cada complicação

Cada complicação aplicável deve responder, sem lacunas, às perguntas: como suspeitar; qual o grau de urgência; quais sinais exigem transferência; quais exames confirmam; qual suporte iniciar imediatamente; qual tratamento específico; qual procedimento ou cirurgia; quais especialistas envolver; como monitorar; quando reavaliar; quais critérios indicam melhora, falha ou alta; e quais sequelas exigem reabilitação.

7.3 Escalonamento

Definir critérios objetivos para mudar de ambulatório para hospital, de enfermaria para terapia intensiva, de tratamento clínico para procedimento, de serviço local para referência e de seguimento habitual para vigilância especializada. Incluir comunicação estruturada durante cada transferência.

7.4 Prevenção de complicações e eventos adversos

Incluir vacinação, profilaxia, controle de fatores predisponentes, revisão medicamentosa, prevenção de trombose, prevenção de lesões por pressão, controle de infecção, segurança de procedimentos, reconciliação terapêutica e educação. Omitir itens sem relação com a doença.

8 Parte VI — Populações e cenários especiais

Abordar separadamente, somente se o diagnóstico apresentar diferenças clinicamente relevantes, neonatos, lactentes, crianças, adolescentes, idosos, gestantes, puérperas, imunossuprimidos, insuficiência renal ou hepática, alergias, comorbidades, deficiência, populações indígenas, áreas rurais, barreiras linguísticas, baixa alfabetização em saúde, cuidados paliativos e acesso limitado.

Para unidades sem imagem, laboratório, especialista, UTI, cirurgia, transporte ou medicamento ideal, definir estabilização, alternativas, teleconsultoria, prazo de transferência e comunicação com o centro receptor.

9 Parte VII — Seguimento, alta e continuidade

9.1 Reavaliação

Definir momento do primeiro retorno, frequência, parâmetros clínicos, exames de controle, resposta esperada, recaída, recorrência, falha e duração do acompanhamento. Separar seguimento clínico, funcional, laboratorial e por especialista.

9.2 Critérios de alta

A alta deve exigir estabilidade, melhora objetiva, tratamento definido, tolerância, ausência de indicação pendente de procedimento, educação do paciente, capacidade de adesão, acesso a retorno e sinais de alarme por escrito. Registrar resultados pendentes e quem será responsável por acompanhá-los.

9.3 Educação e decisão compartilhada

Explicar diagnóstico, prognóstico, benefícios, riscos, alternativas, incertezas, efeitos adversos, sinais de retorno e consequências de não tratar. Usar linguagem acessível, intérprete quando necessário e confirmação de compreensão. Para menores, abordar consentimento e assentimento conforme a legislação e a política institucional.

10 Parte VIII — Segurança, tecnologia e implementação

10.1 Segurança do paciente

Incluir identificação, peso e idade, alergias, reconciliação, unidade de dose, concentração, diluição, dupla checagem de medicamentos de alto risco, comunicação de transição, prevenção de infecção e registro de eventos adversos.

10.2 Farmacovigilância

Definir eventos a monitorar, quando suspender, como substituir, como notificar, como registrar alergia, como prevenir reexposição e como atualizar a guideline após sinal de segurança.

10.3 Telemedicina, imagens e inteligência artificial

Quando aplicáveis, definir qualidade de imagens, consentimento, privacidade, armazenamento, tempo de resposta, limites da avaliação remota, supervisão humana, versão do algoritmo, viés, explicabilidade, critérios para ignorar saída automática e responsabilidade profissional. Omitir esta seção se nenhuma tecnologia for utilizada.

10.4 Indicadores de qualidade

Escolher indicadores que medem decisões relevantes: tempo até avaliação, diagnóstico, tratamento, especialista ou cirurgia; adequação de exames e antimicrobianos; internação; complicações; mortalidade; reinternação; permanência; adesão ao seguimento; equidade; satisfação e eventos adversos.

10.5 Implementação e auditoria

Definir responsáveis, treinamento, disponibilidade de insumos, fluxos, prescrição, materiais para pacientes, checklist, auditoria, feedback, registro de exceções e plano de melhoria. Registrar quando a equipe se afasta da guideline por motivo clínico, recurso indisponível, preferência do paciente, nova evidência ou falha do algoritmo.

10.6 Avaliação econômica

Quando pertinente, considerar custo dos exames, medicamentos, internação, transporte, procedimentos, complicações, alternativas ambulatoriais e impacto orçamentário. Não permitir que custo substitua segurança clínica; usar a análise para explicitar escolhas e restrições.

11 Parte IX — Pacote editorial e anexos

Uma guideline profissional pode ser publicada em camadas:

1. resumo executivo para decisão rápida;
2. fluxograma de triagem e tratamento;
3. texto integral com recomendações e evidência;
4. tabelas terapêuticas e de ajuste;
5. fichas de complicação;
6. checklist assistencial;
7. material para pacientes e cuidadores;
8. formulário de alta e transferência;
9. indicadores e plano de auditoria;
10. registro de versões e mudanças.

11.1 Formulário de recomendação

População	Quem recebe a recomendação e quais subgrupos são excluídos.
Situação clínica	Quando a recomendação é acionada.
Ação	Verbo operacional, intervenção, dose ou intensidade quando aplicável.
Comparador	Alternativa, cuidado usual ou ausência de intervenção.
Desfechos	Benefícios, danos e horizonte temporal.
Força e certeza	Força da recomendação e certeza da evidência.
Exceções	Alergia, comorbidade, falha, indisponibilidade ou grupo especial.
Fonte	Referência específica, versão e data.

11.2 Formulário de intervenção terapêutica

Intervenção e status	Nome, modalidade e classificação: aprovada, protocolo, off-label, excepcional, investigacional ou não recomendada.
----------------------	--

Indicação	Diagnóstico, estágio, gravidade, subgrupo e objetivo.
Regime	Dose, unidade, via, intervalo, duração, preparo e administração.
Segurança	Contraindicações, interações, toxicidade, monitorização e ajustes.
Alternativas	Opção em alergia, falha, contraindicação ou indisponibilidade.
Escalonamento	Quando consultar, internar, transferir ou realizar procedimento.
Descontinuação	Crítérios de resposta, troca, suspensão, descalonamento e retorno.
Evidência	Fonte, população estudada, limitações e força da recomendação.

11.3 Formulário de complicação

Complicação	Nome e relação com o diagnóstico.
Reconhecimento	Sinais, sintomas, fatores de risco e limiar de suspeita.
Confirmação	Exames, imagem, microbiologia ou critérios clínicos.
Primeira resposta	Suporte, estabilização, medidas urgentes e especialista.
Tratamento	Terapia etiológica, procedimento, cirurgia e alternativas.
Monitorização	Parâmetros, frequência, resposta esperada e falha.
Destino	Alta, internação, UTI, transferência e seguimento.
Sequelas	Reabilitação, prevenção de recorrência e vigilância de longo prazo.

12 Auditoria de completude antes da publicação

A equipe deve responder sim, não ou não aplicável a cada verificação. Um “não aplicável” precisa ser justificável internamente, mas não precisa aparecer na versão clínica final.

- [] Título, escopo, versão, autores, revisores e validade estão definidos.
- [] População, cenário e exclusões estão explícitos.
- [] Perguntas clínicas estão delimitadas.
- [] Participação multiprofissional e de pacientes foi considerada.
- [] Conflitos de interesse e financiamento foram declarados.
- [] Definições e critérios de caso estão claros.
- [] Epidemiologia e etiologia são específicas do diagnóstico.
- [] Fatores de risco, proteção e prevenção pertinentes foram incluídos.
- [] Apresentações típicas, atípicas e em populações especiais foram consideradas.
- [] Sinais de alarme e prioridade de atendimento estão claros.
- [] Diagnósticos diferenciais perigosos foram cobertos.
- [] Probabilidade pré-teste e limitações dos testes foram descritas.
- [] Cada exame tem indicação e impacto na decisão.
- [] Imagem, contraste, radiação e sedação foram tratados quando aplicáveis.
- [] Gravidade, prognóstico e escores foram validados ou declarados ausentes.
- [] O tratamento inicial e definitivo está completo.
- [] Toda terapêutica pertinente foi rastreada.
- [] Cada medicamento tem dose, via, intervalo, duração, ajuste e monitorização quando aplicável.
- [] O status aprovado, protocolar, off-label ou investigacional está explícito.

- [] O uso off-label tem justificativa, evidência, riscos e alternativas.
- [] Alergias, contraindicações, interações e desabastecimento foram considerados.
- [] Falha terapêutica e resgate estão definidos.
- [] Procedimentos, cirurgia e reabilitação foram incluídos quando aplicáveis.
- [] Complicações relevantes têm reconhecimento, confirmação e manejo.
- [] Critérios de escalonamento e transferência estão definidos.
- [] Populações especiais pertinentes foram abordadas.
- [] Alta, retorno, resultados pendentes e seguimento estão definidos.
- [] Educação, consentimento e decisão compartilhada foram contemplados.
- [] Segurança medicamentosa e controle de infecção foram contemplados.
- [] Telemedicina, imagens ou IA só aparecem se forem pertinentes.
- [] Recursos, equidade e aplicabilidade local foram avaliados.
- [] Indicadores, auditoria e registro de exceções estão definidos.
- [] Atualização e vigilância de evidência têm responsável e prazo.
- [] Não há recomendações sem fonte ou extrapolações ocultas.
- [] Itens não aplicáveis foram omitidos da versão clínica final.
- [] Fluxograma, texto integral, anexos e materiais para pacientes são consistentes.
- [] O documento foi revisado clínica e tecnicamente.

Critério de aprovação

A guideline só deve ser liberada quando cada item aplicável tiver conteúdo verificável, os itens condicionais tiverem critérios de acionamento e as lacunas restantes estiverem declaradas. “Sem lacunas” significa que nenhum tópico pertinente foi esquecido; não significa inventar respostas para perguntas que a evidência ou o diagnóstico não sustentam.

13 Referências de elaboração

- [1] Organização Mundial da Saúde. **WHO handbook for guideline development**, 2.^a edição. O handbook descreve processos e procedimentos para planejar, desenvolver e publicar guidelines segundo padrões da OMS. [Acessar fonte](#).
- [2] RIGHT Working Group. **Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare (RIGHT Statement)**. Checklist de 22 itens para relato transparente de informação básica, contexto, evidência, recomendações, revisão, qualidade, financiamento e conflitos de interesse. [Acessar fonte](#).
- [3] AGREE Research Trust. **AGREE II: Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II — Users’ Manual and 23-item Instrument**. Instrumento para avaliar escopo, participação, rigor, clareza, aplicabilidade e independência editorial. [Acessar fonte](#).
- [4] CONITEC. **Diretrizes clínicas e processos de elaboração — página oficial de documentos de elaboração**. Reúne materiais brasileiros para elaboração, adaptação, avaliação e implementação de diretrizes. [Acessar fonte](#).
- [5] Ministério da Saúde e CONITEC. **Processo brasileiro para elaboração de diretrizes clínicas**. Publicação oficial disponível no portal Gov.br. [Acessar documento](#).

14 Nota final de uso

Este framework é um instrumento de planejamento editorial e de elaboração. Ele não substitui uma guideline específica, uma bula, um protocolo institucional, uma decisão regulatória ou o julgamento clínico. Ao gerar uma guideline para um diagnóstico concreto, aplicar a regra de filtragem: **incluir somente o que for pertinente, sustentado e acionável para aquele diagnóstico; omitir o que não existir ou não for condizente; e declarar explicitamente as incertezas que permanecerem.**